



สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม
Research and Service Institute for Autism

ชื่อแผนงานวิจัย

(ภาษาไทย) โครงการวิจัยด้านสังคมและสวัสดิการสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึม

(ภาษาอังกฤษ) Social and Welfare for People with Autism Spectrum Disorder

ชื่อโครงการวิจัยย่อย 4

(ภาษาไทย) โปรแกรมการฝึกทักษะสังคม สำหรับวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม

(ภาษาอังกฤษ) Social Skills Interventions for Youth with Autism Spectrum Disorder

สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรกฎาคม 2562

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ประกอบเอกสารเสนอของบประมาณของสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการวิจัยด้านสังคมและสวัสดิการสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึม
(ภาษาอังกฤษ) Social and Welfare for People with Autism Spectrum Disorder

ชื่อโครงการวิจัยย่อย 4

(ภาษาไทย) โปรแกรมการฝึกทักษะสังคม สำหรับวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม
(ภาษาอังกฤษ) Social Skills Interventions for Youth with Autism Spectrum Disorder

ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

***1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย**

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะทำงานด้านสังคมและสวัสดิการ สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม

1.1 หัวหน้าโครงการ

1.1.1 นางปรีศนา อานจำปา

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย

1.2.1 นางธิรากร มณีรัตน์

1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรภรณ์ เจนใจวิทย์

1.2.3 นางภัทรา ฤชวรารักษ์

1.2.4 นางปรียากร สบาย

1.2.5 นางสาวชล สิงห์สุวรรณ

1.2.6 นางดลฤทัย อีสริยยศปัญญา

1.2.7 นางสาวเตชินี ดวงโพธิ์พิมพ์

1.3 หน่วยงานหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 หน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลขอนแก่น สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย

2. ประเภทการวิจัย

การวิจัยผสมวิธี ชนิดตรวจสอบสองขั้นตอน (two-phase exploratory design) ในรูปแบบ (QUAN emphasized) (Creswell & Clark, 2007)ⁱ โดยผลของระเบียบวิธีที่หนึ่งคือเชิงคุณภาพ (qualitative) ช่วยพัฒนาหรือเป็นข้อมูลในระเบียบวิธีที่สองคือเชิงปริมาณ (quantitative) ซึ่งการศึกษาเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้ถูกศึกษา (emic) ที่มีความหลากหลายซับซ้อนตามบริบทสังคมวัฒนธรรม ผ่านทัศนะของคนนอก (etic) คือนักวิจัย จากนั้นนำข้อมูลเชิงคุณภาพสู่การพัฒนาโปรแกรม เพื่อพัฒนาทักษะสังคมของวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม โดยการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต้องแยกจากกัน (Munhull, 1993)ⁱⁱ

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมและมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์)

4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)

วางแผนยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และการเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

5. คำสำคัญ (Keywords) ของการวิจัย

(ภาษาไทย) ทักษะสังคม, วัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม, โปรแกรมการฝึก

(ภาษาอังกฤษ) Social Skills, Youth with Autism Spectrum Disorder, Intervention

6. ความสำคัญ และที่มาของปัญหา

ออทิซึม หรือกลุ่มอาการผิดปกติของสติปัญญา (autism spectrum disorder: ASD) หมายถึง ภาวะที่มีลักษณะมีความบกพร่อง 2 ด้าน 1) มีความบกพร่องอย่างชัดเจนในการสื่อสารทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction and social communication) ในหลากหลายบริบทและ 2) แบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จำกัด ซ้ำๆ (Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities) ตามเกณฑ์คู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (American Psychiatric Association, 2013) ⁱⁱⁱ เป็นความพิการประเภทที่ 7 ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ

ปัจจุบันอุบัติการณ์ของออทิซึมสเปกตรัมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอเมริกาพบบุคคลออทิซึมสเปกตรัมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10-17 ต่อปี หรือ 1:150 ของอัตรากำเนิดประชากร ส่วนในอังกฤษมีอัตรา 1:64 โดยเกิดขึ้นกับเพศชายมากกว่าหญิง 4 เท่า พบในทุกเชื้อชาติทุกเศรษฐกิจ และคาดว่าอุบัติการณ์น่าจะเพิ่มขึ้นอีก และพบว่าบุคคลออทิซึมจำนวน 2 ใน 3 มีภาวะต้องพึ่งพิงผู้อื่น และต้องการผู้ดูแลตลอดชีวิต ในขณะที่จำนวน 1 ใน 3 มีภาวะพึ่งพาตนเองได้พอสมควร โดยมีเพียงร้อยละ 1-2 ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้เต็มที่ (Fully independent)

สำหรับประเทศไทย พบอัตราป่วยโรคออทิซึมได้ 6 คนในประชากรทุกๆ 1,000 คน คาดว่าทั่วประเทศจะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 300,000 คน ในจำนวนนี้ยังเข้าถึงบริการน้อยมาก ประมาณร้อยละ 10 หรือปีละเพียง 30,000 กว่าคนเท่านั้น ที่ผ่านมาได้พบปัญหาที่สำคัญคือประชาชนยังเข้าใจเรื่องโรคออทิซึมสเปกตรัมน้อย ทำให้จำนวนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ การศึกษา และการช่วยเหลือทางสังคมมีน้อยมาก โดยพบเพียงประมาณร้อยละ 15 ของผู้ป่วยออทิซึม ซึ่งสังเกตได้จากรายงานจำนวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตที่กระจายตามเขตสาธารณสุขรายจังหวัด ปี 2555 พบว่า มีผู้ป่วยออทิซึมเข้าถึงบริการเพียง 25,537 ราย

บุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น ส่วนใหญ่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แต่ด้วยการด้อยทักษะการเข้าสังคมทำให้เกิดความยุ่งยากในชีวิต ส่งผลกระทบทั้งด้านการเรียน การปรับตัว และปัญหาทางจิตใจ^{iv} เนื่องจากยังไม่มีวิธีการรักษาใดที่เป็นที่เฉพาะ การบำบัดรักษาในปัจจุบันเป็นการรักษาตามความจำเป็น และเป็นการฟื้นฟูศักยภาพเฉพาะบุคคลเพื่อการดำรงชีวิตอย่างอิสระ โดยการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ทั้งในส่วน

ของการแพทย์ การจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ตลอดจนสวัสดิการสังคม และการดำเนินชีวิตในชุมชน

การพัฒนาทักษะสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลที่มีภาวะออทิซึมออกจากโลกของตนเอง และเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่น ซึ่งจากสภาพการขาดทักษะสังคมของบุคคลที่มีภาวะออทิซึม ที่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันในแต่ละคน แนวทางการพัฒนาทักษะสังคมที่เหมาะสมกับแต่ละคนจึงแตกต่างกัน การสอนทักษะสังคมมีหลายวิธี เช่น การสอนโดยตรง (direct skills instruction) การกระตุ้นเตือนก่อน (antecedent prompting) การใช้เพื่อนเป็นสื่อ (peer-mediated, peer tutoring, peer group) การอ่านจิตใจ (mind reading) เรื่องราวทางสังคม (social story) ฟลอร์ไทม์ (floor time) การควบคุมตนเอง (self-monitor) การดูแบบอย่างจากวิดีโอ (video modeling) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) การเข้าถึงมุขตลกต่าง ๆ (appreciation of humor) การมีผู้ช่วยเหลือ และเกม เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นว่าวิธีการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้บุคคลที่มีภาวะออทิซึมสามารถพัฒนาทักษะสังคม แต่จำเป็นต้องเลือกอย่างรอบคอบและให้เหมาะสมกับความต้องการและระดับพัฒนาการของแต่ละคน

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า การฝึกทักษะสังคม (social skill training) เป็นวิธีที่นิยม และช่วยให้วัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม สามารถปรับตัวกับสังคมแวดล้อมดีขึ้น^{v vi vii} ดังรายงานการทบทวนวรรณกรรม RCT 5 เรื่อง^{viii}

ในกลุ่มเป้าหมาย 196 รายชี้ให้เห็นว่า Social skills groups 12 สัปดาห์ ทำให้เพิ่มสมรรถนะทางสังคม social competency และ คุณภาพของสัมพันธภาพ (friendship quality) เพิ่มการแสดงออกและความรู้ทางสังคม และ หากได้รับ SST ระยะยาว 24 สัปดาห์ จะได้ผลดีขึ้น ส่วน Williams-White et al. (2007) ทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการศึกษาแล้ว 14 เรื่อง^{ix} ที่ใช้การฝึกทักษะสังคมแบบกลุ่ม โดยมีเพียงเรื่องเดียวที่ใช้กลุ่มควบคุม (RCT) (Provencal 2003), 2 เรื่อง ใช้วิธี manualized treatment (Webb et al. 2004^x; Barnhill 2002)^{xi} และ 4 เรื่องศึกษาในวัยรุ่นอายุมากกว่า 12 ปี (Mesibov 1984; Provencal 2003^{xii}; Webb et al. 2004^{xiii}; Barnhill 2002^{xiv}) ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาใดที่ติดตามผลในระยะยาว และการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ (parent-assisted model of social skills instruction)

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาและความถี่ ของโปรแกรมยังหลากหลาย แม้ส่วนใหญ่จะมีเทคนิคคล้ายคลึงกันคือ ประกอบด้วย การสอนในสถานการณ์จริง (incidental teaching) การสอนบอกบทล่วงหน้า (social stories and scripts) การใช้บทบาทสมมติ (role-plays) รวมทั้งการกำกับตนเอง (self-monitoring) and peer-mediated activities (e.g., peer education, peer buddy) ตัวอย่างเช่น Lopata and colleagues^{xv} ที่มีขั้นตอนดังนี้ teaching, modeling, role-playing, and feedback of a social skill และ Gresham et al.^{xvi} แนะนำโปรแกรมที่ทำกับกลุ่มขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วย behavioral modeling; coaching; behavioral rehearsal; and performance feedback

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา โปรแกรมการฝึกทักษะสังคม สำหรับวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม โดยเฉพาะทักษะใหม่ เช่น การริเริ่มสร้างมิตร การสานต่อมิตรภาพ ทั้งกับเพื่อนวัยเดียวกัน ตลอดจนการมีเพื่อนต่างเพศ โดยใช้สื่อตัวอย่าง การฝึกแสดง การสะท้อนผล เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมไทย เข้าใจสิ่งที่ควรกระทำ นำมาซึ่งความสุข และเป็นใบเบิกทางแห่งความสำเร็จในชีวิต เปิดประตูสู่มิตรภาพ และโอกาสในการมีงานทำและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป

7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะสังคม ต่อทักษะสังคมของวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม

8. ขอบเขตของการวิจัย

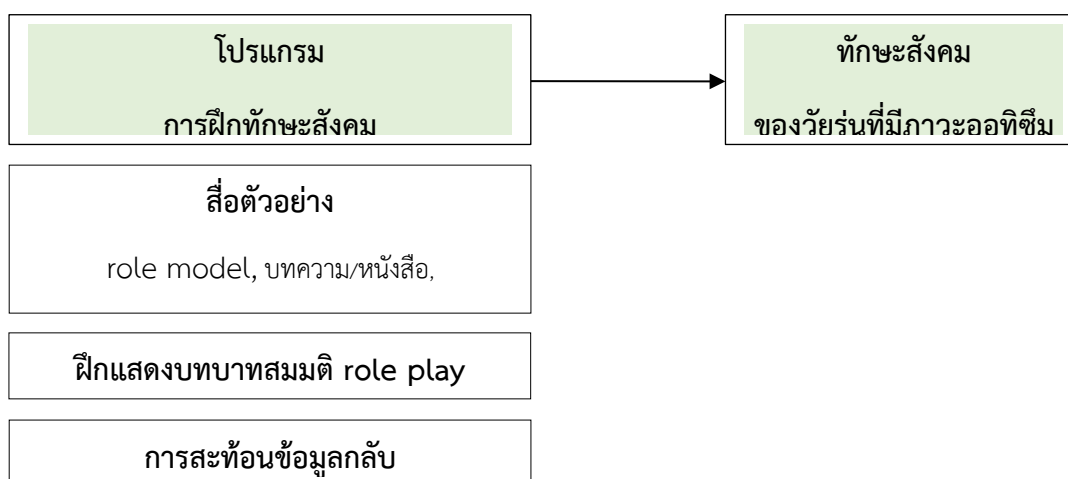
8.1 ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย

ดำเนินการในจังหวัดขอนแก่น

8.2 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย

ศึกษาช่วง สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563

9. กรอบแนวความคิดของการวิจัย



10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

10.1 ทักษะสังคมของวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม

10.1.1 ภาวะออทิซึมสเปกตรัม

ออทิสติกหรือภาวะออทิซึมสเปกตรัม (autism spectrum disorder) เป็นความผิดปกติของสมองแบบหนึ่งที่เกิดในวัยเด็ก นับแต่ปี 1799 จนถึงปัจจุบัน คำนิยามของออทิซึมได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด คำว่า “autism” เป็นคำานาม มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก autos = self หรือ “same” แปลว่า “ตัวเอง” ซึ่งหมายถึง “บุคคลที่มีภาวะออทิซึม โดยทั่วไปมักแยกตัวออกจากสังคม และขาดปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์” ส่วนคำว่า “-ism” มีรากศัพท์มาจาก middle English ว่า isme รากศัพท์มาจาก old French Latin ว่า ismus รากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า ismos ซึ่งมีความหมายว่า การกระทำ/วิธีปฏิบัติที่สม่ำเสมอเป็นกิจวัตร^{xvii,xviii,xix} และพบว่าเด็กแต่ละคนมีความรุนแรงของโรคแตกต่างกันค่อนข้างมากจึงนิยมเรียกโรคนี้ว่า ออทิซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์ (autism

spectrum disorder) ในทางการแพทย์จัดโรคนี้อยู่ในกลุ่ม Pervasive Developmental Disorder หรือเรียกสั้น ๆ ว่า PDD

ระยะแรกเชื่อว่ามีสาเหตุจากอาหารจึงใช้วิธีการรักษาทางชีวเคมีและอาหาร ปัจจุบันใช้วิธีการบูรณาการประสาทสัมผัส

ลักษณะของภาวะออทิซึมสเปกตรัม ความบกพร่องของอาการออทิซึมเล็กน้อยต่างกันคล้ายสเปกตรัม โดยแสดงอาการบกพร่อง 2 ด้าน คือการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และพฤติกรรมซ้ำ ๆ ซึ่งจะแสดงอาการตั้งแต่วัยเด็กภายใน 2 ขวบปีแรก และอาการจะต้องส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกต่อการทำหน้าที่สำคัญในชีวิตปัจจุบัน เช่นการอยู่ในสังคม การเรียนรู้และการทำงาน



ภาพ 1 ลักษณะของภาวะออทิซึมสเปกตรัม

อุบัติการณ์ของโรค ในสหรัฐอเมริกามีการรายงานอุบัติการณ์ของโรคออทิซึมสเปกตรัมตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 (พ.ศ. 2513) โดยถ้าวินิจฉัยตามคู่มือการวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกา (American Psychiatric Association, 2000) จะพบเด็กออทิซึมสเปกตรัม 4-5 คนในประชากร 10,000 คน แต่หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger's syndrome) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคออทิซึมสเปกตรัมที่มีอาการไม่รุนแรง จะมีความชุกถึง 36 คน ในประชากร 10,000 คน ปัจจุบันพบบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ต่อ 59 ของประชากรเด็กอายุ 8 ปี ^{xx}

ในประเทศไทย พบอุบัติการณ์ของโรคสูงขึ้น โดยกลุ่มที่มีอาการรุนแรงพบในอัตรา 2 : 10,000 คน แต่กลุ่มที่มีอาการน้อยพบ 1-2 คนต่อประชากร 1,000 คนหรืออาจมากกว่านั้น ซึ่งจากการศึกษาภาวะออทิซึมสเปกตรัมในประเทศไทยและการดูแลรักษาแบบบูรณาการในระดับประเทศ พบว่าความชุกของโรคออทิซึมสเปกตรัมในเด็กไทยอายุ 1-5 ปี เท่ากับ 9.9 : 10,000 คน ปัจจุบันยอดตัวเลขของไทยต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และบุคคลออทิซึมสเปกตรัม 1 คนต่อเด็ก 166 คน^{xxi} กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าทั่วประเทศมีเด็กอายุ 2-5 ขวบ ที่เป็นออทิสติก 18,220 คน แต่เข้าถึงบริการในปี 2560 เพียงร้อยละ 35 ทั้งนี้ เด็กที่เป็นออทิสติก ช่วงแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี เด็กจะเติบโตและมีพัฒนาการเหมือนเด็กปกติทั่วไป โดยพัฒนาการจะเริ่มผิดปกติปรากฏให้เห็นในช่วงย่างเข้าขวบปีที่ 2 เด็กจะพูดซ้ำ สื่อสารไม่ได้

เกณฑ์การวินิจฉัยทางการแพทย์ สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ได้กำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยโรคออทิซึม สเปกตรัม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 ดังนี้ (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-5)

A. มีความบกพร่องอย่างยาวนานด้าน การสื่อสารทางสังคมและด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในหลายบริบท เช่น	B. มีพฤติกรรม ความสนใจหรือกิจกรรมที่ชอบ เป็นแบบแผนตายตัวหรือซ้ำๆ เช่น
A.1 บกพร่องในถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติทางด้าน อารมณ์ที่เกี่ยวกับการสังคม	B.1 การเคลื่อนไหว การใช้สิ่งของหรือคำพูดมีอาการเป็นแบบแผนตายตัวหรือซ้ำๆ
A.2 บกพร่องทางพฤติกรรมการสื่อสารแบบ บอวจนะภาษา	B.2 การยึดหรือยืนกรานอยู่กับสิ่งเดิมๆ เหมือนเดิม ยึดอย่างไม่ยืดหยุ่น
A.3 การพัฒนา การดำรงไว้ และการเข้าใจ เรื่องสัมพันธ์ภาพบกพร่อง	B.3 มีความสนใจที่จำกัดมากๆ ยึดติดแน่น กับความสนใจนั้นจนผิดปกติทั้งในแง่การเอาจริงเอาจังหรือจุดที่สนใจ
	B.4 ระบบรับสัมผัส มีการตอบสนองไว-ช้า

ตาราง 1 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคออทิซึมสเปกตรัม สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5

ระดับความรุนแรงของโรค ภาวะออทิซึมสเปกตรัม เป็นลักษณะอาการที่มีความแตกต่างกันได้มาก อาการมีหลายอย่าง สามารถแบ่งระดับความรุนแรงตามความต้องการความช่วยเหลือเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรง	A การสื่อสารทางสังคม และด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	B พฤติกรรมที่เป็นแบบแผนตายตัว หรือซ้ำๆ
ระดับ 1 ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย	สังเกตความบกพร่องได้ แต่ไม่ต้องได้ รับการช่วยเหลือ ลำบากในการเริ่มต้น สนทนา ไม่สำเร็จหรือมีความผิดปกติ ในการตอบสนองทางสังคม ไม่ค่อย สนใจในปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ล้มเหลว ในการโต้ตอบ ต้องใช้ความพยายาม สร้างเพื่อนและไม่สำเร็จ	พฤติกรรมรบกวนการทำงาน ยากใน การเปลี่ยนกิจกรรม มีปัญหาในการ จัดการและวางแผน
ระดับ 2 ต้องการความช่วยเหลือ (อย่างเป็นทางการ) ปานกลาง	บกพร่องชัดเจนในการสื่อสาร ยังมี ความบกพร่องถึงแม้จะให้การช่วยเหลือ มีความจำกัดในการเริ่มต้น สนทนา มีความผิดปกติในการตอบ สนองทางสังคม	พฤติกรรมสามารถสังเกตเห็นได้โดย คนทั่วไป รบกวนสถานการณ์ต่างๆ ยากลำบากในการเปลี่ยนความสนใจ หรือการกระทำ
ระดับ 3 ต้องการความช่วยเหลือ (อย่างเป็นทางการ) มาก	บกพร่องมากในการสื่อสาร มีข้อจำกัด มากในปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตอบ สนองทางสังคมน้อย	พฤติกรรมรบกวนในทุกสถานการณ์ ลำบากมากในการเผชิญเปลี่ยนแปลง

ตาราง 2 ความรุนแรงของภาวะออทิซึมสเปกตรัม

พฤติกรรมที่น่าสงสัยในเด็กโต สามารถสังเกตว่าอาจจะมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมได้ดังนี้

ความผิดปกติทางภาษาในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น	ความผิดปกติของพฤติกรรม ความสนใจที่มีลักษณะซ้ำๆจำกัด
- ไม่ค่อยสบตาเวลาพูดคุยด้วย • ชอบเก็บตัวหรืออยู่ตามลำพัง - มักเล่นคนเดียว • ไม่ค่อยมีเพื่อน • ไม่มีเพื่อนสนิท - เข้ากับเพื่อนได้ยาก • ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น - ไม่เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมทำให้ทำตัวผิดกาลเทศะ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่บ่อยๆ - สานต่อบทสนทนาไม่ค่อยได้ - ใช้ภาษาพูดที่ไม่เหมาะกับกาลเทศะพูดแบบขวานผ่าซาก - ไม่เข้าใจคำพูดซ้ำขึ้นอุปมาอุปไมย	- ชอบคิดซ้ำซากหรือทำอะไรซ้ำๆ - ปรับตัวยากทำกิจวัตรต้องมีขั้นตอน เหมือนเดิมสลับสับเปลี่ยนไม่ได้ - หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องที่ตนเองสนใจ เช่นรูปทวารฉลากผลิตภัณฑ์

ตาราง 3 พฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อภาวะออทิซึมสเปกตรัมในเด็กโต

10.1.2 วัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อลูกออทิซึมเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่ส่งผลต่ออารมณ์จิตใจของลูก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์นี้ ถือเป็นเรื่องปกติในวัยรุ่น ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น เพื่อน การแข่งขัน ความคาดหวังของพ่อแม่ การเป็นที่ยอมรับของเพื่อนมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของลูก เป็นแรงกระตุ้นต่ออารมณ์ทำให้ลูกวัยรุ่นเครียดกังวลได้ พ่อแม่อาจเห็นว่าช่วงนี้ลูกมีอารมณ์แปรปรวนง่าย หงุดหงิดง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย ถ้าลูกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะมีอาการกิริยาท่าทางที่เป็นการทำลายได้ พ่อแม่ต้องใจเย็น หนักแน่น และรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง เปิดใจให้เกียรติและปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง ไม่ใช่เลี้ยงดูแบบเด็กเล็กๆ ตลอดเวลา ต้อง “ยอมรับ” ความเป็นวัยรุ่นในแบบที่ลูกเป็น และ “เข้าใจ” ว่า

- 1) มีการเปลี่ยนแปลงภายในตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่หนักสำหรับลูกวัยรุ่น
- 2) มีความบกพร่องทั้งในการประมวลผลรับสัมผัส 7 ด้านและการแสดงอารมณ์ในทางสังคม
- 3) มีข้อจำกัดในการสื่อสารของลูกที่มีภาวะออทิซึม

สำหรับเด็กโดยทั่วไปจะได้รับการเตรียมความพร้อมทักษะด้านต่างๆ และเรียนรู้ทักษะสังคมจากการฟัง การสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวทุกวัน แต่บุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ อาจเนื่องจากธรรมชาติของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ที่มีความบกพร่องของการประมวลผลระบบรับสัมผัส และการแสดงอารมณ์ในทางสังคมดังกล่าว ทำให้เหมือนมีกำแพงแก้วมากขึ้นระหว่างเด็กกับสังคมรอบข้าง จากการศึกษานี้ของ The Camberwell study^{xxii} ความบกพร่องดังที่กล่าวมา ทำให้บุคคลที่มีภาวะออทิซึม ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม บุคคลที่มีภาวะออทิซึม แต่ละคนจะไม่เข้าใจว่า คนอื่นมีความคิดมีมุมมองกับตนเองอย่างไร แต่ละคนมีความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งทำให้ประสบการณ์ยากในความเชื่อทัศนคติของผู้อื่น ผลที่ตามมาก็คือเด็ก

เหล่านี้ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าคนอื่นจะพูดหรือทำอะไรในสังคมที่แตกต่าง เรียกความบกพร่องนี้ว่าทฤษฎีของจิตใจ (theory of mind) ซึ่ง Baron-Cohen^{xxiii} อธิบายทฤษฎีของจิตใจว่า บุคคลที่มีภาวะออทิซึม ไม่สามารถเข้าใจมุมมองของผู้อื่นหรือเข้าใจเหตุการณ์ที่บุคคลอื่นมีมุมมองที่แตกต่างจากตนเอง

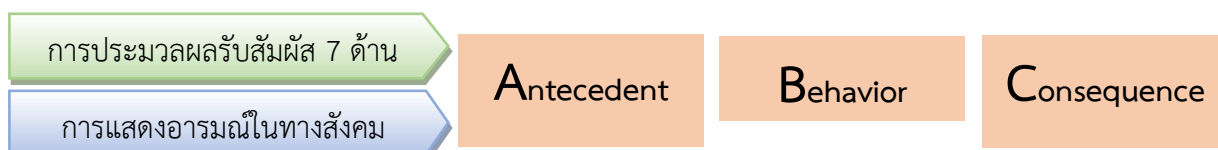
ดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องปรับวิธีการดูแลให้เหมาะสมกับความต้องการ ข้อจำกัดความสามารถ และการเจริญเติบโตตามพัฒนาการของลูกวัยรุ่น และสื่อสารกับวัยรุ่นด้วยความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว สามารถก้าวข้ามและผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวนี้ได้อย่างมีความสุข เพื่อช่วยให้ลูกเรียนรู้และแสดงออกที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดพัฒนาการจากวัยเด็ก สู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กที่พึ่งพิงพ่อแม่เพียงเพื่อการอยู่รอด พัฒนาสู่วัยรุ่นที่เริ่มพึ่งตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และจะพัฒนาสู่ผู้ใหญ่ที่จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นเพื่อการอยู่อย่างมีความหมาย นำพาบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมออกจากโลกของตนเอง และเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่น สร้างความคุ้นเคยและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น เด็กจะเกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และจะสามารถพัฒนาตนเองให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าเด็กทั่วไปได้

10.1.3 ทักษะสังคม ของวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม

ทักษะสังคม เป็นทักษะที่สำคัญต่อการดำรงชีพและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมทุกระดับ ตั้งแต่สังคมเล็ก ๆ คือ ครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน อาชีพ ชุมชน ประเทศ จนกระทั่งสังคมโลก ที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยอาศัยทักษะสังคม ทักษะสังคมนับเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ทำให้เป็นคนมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ดี สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ในวัยเด็ก เด็กทุกคนต้องการเพื่อนเล่น เพื่อนเรียน และเพื่อนร่วมกิจกรรม เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ต้องการเพื่อนร่วมงาน เพื่อนคู่คิด คนที่จะประสบความสำเร็จได้ นอกจากมีความสามารถในการทำงาน จำเป็นต้องมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ซึ่งคือการมีทักษะสังคมสูงนั่นเอง การขาดทักษะสังคมอาจก่อให้เกิดผลลบต่อบุคคลเป็นอันมาก เช่น ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยาก ก่อให้เกิดความขัดแย้งและมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ขาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นต้น

สาเหตุของพฤติกรรมที่แตกต่าง ของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม เนื่องจากมีความบกพร่อง 2 ประการ คือ การประมวลผลรับสัมผัส และ การแสดงอารมณ์ในทางสังคม โดยที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดหรือเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา ส่วนใหญ่พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจำวัน เช่น กิน นอน พูด เดิน ทำงาน เกิดจากสิ่งเร้ามากระตุ้น เรียกว่า เงื่อนไขนำ (antecedents: A) ซึ่งส่งผลทำให้เกิดพฤติกรรม (behavior: B) อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วจึงเกิดผลกรรมตามมา (consequences: C) องค์ประกอบของพฤติกรรม 3 ข้อนี้เรียกย่อ ๆ ว่า A-B-C จะดำเนินต่อเนื่องกันไป โดยผลกรรมจะกลับมาเป็นเงื่อนไขใหม่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ตามมา และเกิดผลกรรมใหม่ต่อไป ซึ่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ เชื่อว่าอัตราการเกิดพฤติกรรม (B) ขึ้นอยู่กับผลกรรม (C) คือการเสริมแรง (reinforcement) หรือการลงโทษ ทั้งทางบวกและทางลบ จึงให้ความสำคัญต่อการเสริมแรง ว่ามีผลทำให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวรยิ่งขึ้น

สำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึม สิ่งเร้า (A) มีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีความบกพร่อง 2 ประการ คือ การประมวลผลรับสัมผัส และ การแสดงอารมณ์ในทางสังคม ดังนี้



ภาพ 2 องค์ประกอบของการแสดงพฤติกรรมทักษะสังคม

1) การประมวลผลรับสัมผัส 7 ด้าน

บุคคลที่มีภาวะออทิซึม มีความบกพร่องในการประมวลผลรับสัมผัส 7 ด้าน หรือ sensory integration (SI) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานภายในสมอง ที่คอยจัดระเบียบคัดกรองความรู้สึกต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นร่างกาย ผ่านระบบประสาทรับสัมผัส 7 ด้าน และสั่งให้ร่างกายแสดงพฤติกรรมออกมา ระบบรับสัมผัสทั้ง 7 ประกอบด้วย

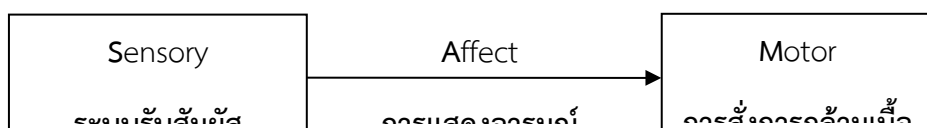
- 1.1) การได้กลิ่น (olfactory system: sense of smell)
- 1.2) การมองเห็น (visual system: sense of sight)
- 1.3) การรับสัมผัสทางผิวหนัง (tactile or somatosensory system: sense of touch)
- 1.4) การทรงตัว (vestibular: sense of body position)
- 1.5) การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อต่อ (proprioception: sense of balance)
- 1.6) การได้ยิน (auditory system: sense of hearing)
- 1.7) การรับรส (gustatory system: sense of taste)

ซึ่งหากการรับรู้ผ่านระบบรับสัมผัสทั้ง 7 ด้านไม่สมดุล (เช่น รับสัมผัสไวเกิน หรือรับสัมผัสช้าเกิน) ก็จะมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา ตัวอย่างเช่น ในการรับประทานอาหาร คนเราทั่วไปต้องใช้การมองเห็น การดมกลิ่น การสัมผัสและการรับรสเพื่อแยกแยะประเภทของอาหาร ใช้การรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อในการนำอาหารเข้าปาก และการทรงตัวนั่งรับประทานอาหารได้ตลอดมื้อ แต่บุคคลที่มีภาวะออทิซึมบางคนอาจมีภาวะการรับสัมผัสที่ไวเกิน/ช้าเกิน เช่น มีการรับรู้รสชาติด้านกลิ่นหรือรสชาติอาหารที่ “ไวเกิน” ก็จะหลีกเลี่ยงการกินอาหารบางชนิด หรือถ้ามีการรับรู้รสชาติที่ “ช้าเกิน” ก็จะกระตุ้นตัวเองด้วยการกัดแทะสิ่งของที่ไม่ใช่อาหารเช่น ของเล่น ดินสอ เป็นต้น

ดังจะเห็นในบางคน สมองมีการแปลและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับสัมผัส ผ่านระบบรับสัมผัสทั้ง 7 ด้านแตกต่างจากคนทั่วไป (ไวเกิน/ช้าเกิน) ก่อให้เกิดความไม่สมดุล ส่งผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น จับดินสอไม่เป็น ใช้ทั้งมือกำดินสอ (ใช้นิ้วจับไม่เป็น) ทำให้บกพร่องด้านการเขียน กล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรง ไม่สามารถหยิบจับช้อน/ส้อมเข็มได้ เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่เด็กๆ ไม่สามารถทำกิจกรรมตามวัยได้ ก็อาจส่งผลถึงความกล้าแสดงออก และความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กได้

2) การแสดงอารมณ์ในทางสังคม

บุคคลที่มีภาวะออทิซึม มีอาการบกพร่องการแสดงอารมณ์ในทางสังคม ทั้งแบบถ้อยที่ ถ้อยปฏิบัติกันไปมา หรือตอบสนองกันไปมา การแสดงอารมณ์ร่วมกัน การรับรู้อารมณ์ร่วมกันและการแสดงสีหน้า ร่วมกัน (affect) มีอาการบกพร่องในการที่จะเริ่มต้นพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ภาพ มีความบกพร่องในการดำรงไว้ ซึ่งสัมพันธ์ภาพ ขาดความเข้าใจคนอื่น ไม่สามารถเข้าใจในมุมมองคนอื่นและมีความบกพร่องในพฤติกรรมสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด (nonverbal communicative behaviors) บกพร่องการใช้แสดงสีหน้า ไม่สามารถตระหนักหรือ ตีความการแสดงท่าทางของคนอื่น มีข้อจำกัดในสื่อสารบอกความรู้สึกอารมณ์ตนเองหรือพูดเล่าได้ไม่ชัดเจน ความ บกพร่องของการประมวลผลระบบรับสัมผัส และการแสดงอารมณ์ในทางสังคม ดังกล่าวส่งผลต่อการสั่งการกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่มีภาวะออทิซึม ได้ตั้ง แผนภาพ SAM ดังนี้



ภาพ 3 ระบบรับสัมผัส การแสดงอารมณ์ และการสั่งการกล้ามเนื้อ ของบุคคลที่มีภาวะออทิซึม

ทักษะสังคมที่สำคัญสำหรับวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม มีดังนี้

- 1) **ทักษะที่ใช้ในการเรียน** ได้แก่ทักษะการฟัง การสื่อสาร การพูด, ความมุ่งมั่นเอาใจใส่ ความขยัน รับผิดชอบในการทำงาน ส่งการบ้านตามกำหนดการทำตามคำแนะนำ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ห้องเรียนและโรงเรียนการยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนเอง เช่น มาสายถูกตัดคะแนนอาสาช่วยเพื่อน หรือครูทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ช่วยคุณครูแจก หรือรวบรวมสมุดการบ้านของเพื่อนๆ ในแต่ละรายวิชา เป็นต้น
- 2) **ทักษะการควบคุมตนเอง** ปัญหาในเรื่องการควบคุมตนเอง โดยเฉพาะการจัดการ อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ^{xxiv} เนื่องจากความไม่ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงยาก และมักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาเมื่อต้องเจอกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่จะหงุดหงิดคับข้องใจ (APA, 2013) อีกทั้งมีความวิตกกังวลสูงซึ่ง ความวิตกกังวลนี้จะส่งผลต่อการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น (Eussen et al., 2013) ดังนั้นการฝึกการควบคุมอารมณ์ และการจัดการกับความคับข้องใจของตนเองก็เป็นส่วนสำคัญที่บุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมต้องได้รับการฝึก (นาถลดา ตะวันกาญจน์โชติ, 2554) ทักษะดังกล่าวประกอบด้วยการจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล ความ โกรธ ความยืดหยุ่น การปฏิบัติตนเมื่อต้องเปลี่ยนแปลง (Cotugno, 2009)
- 3) **ทักษะการสื่อความหมายทางสังคม** จากการศึกษาพบว่าการสอนด้านการสื่อความ หมายทางสังคม ส่วนใหญ่ในบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมวัยเรียนจะไม่สอนการสื่อสารขั้นต้น (เช่น สอนคำศัพท์ ต่างๆ เป็นต้น) แต่จะเป็นการสอนทักษะการสื่อสารขั้นสูงทั้งในเรื่องท่าทางภาษาพูด และการโต้ตอบในสถานการณ์ ต่างๆ เนื่องจากบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมไม่สามารถตีความหมายของคำหรือภาษาท่าทางผู้อื่นได้ จึงทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมทางสังคม (นาถลดา ตะวันกาญจน์โชติ, 2554) ลักษณะทักษะการสื่อสารที่สอนจะประกอบด้วย การขออนุญาตก่อนลงมือกระทำ เช่น การขอยืมของใช้ปากกา ดินสอ ยางลบ จากเพื่อน การขออนุญาตไป ห้องน้ำ หรือออกไปนอกห้องเรียน เป็นต้น รวมทั้งการแบ่งปันของอุปกรณ์การเรียนและของเล่น การขอโทษ และ การให้อภัย ควรฝึกให้รู้จักกล่าวคำ “ขอโทษ” และการกล่าวคำให้อภัยเพื่อน “ไม่เป็นไร” ในชั้นเรียน โดยการพูดคุย

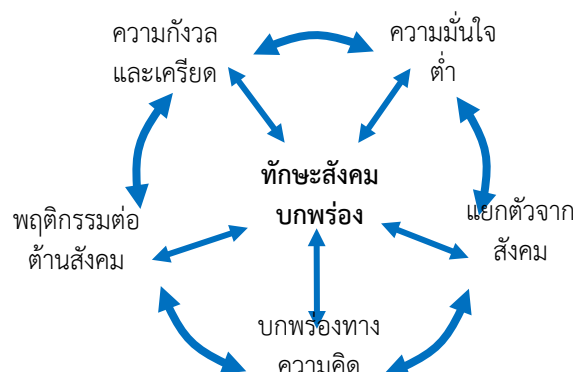
เชื่อมโยงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้าน ไปสู่การปฏิบัติตนในชั้นเรียนของบุตรหลาน เช่น เมื่อพ่อแม่ส่งขนมให้ครูฝึกให้ลูกพูด “ขอบคุณครับ/ค่ะ” พร้อมทั้งสอนว่าเมื่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเพื่อน ครูหรือผู้ใหญ่คนอื่นส่งของให้ลูกควรกล่าวขอบคุณทุกครั้ง เป็นต้นการบอกความต้องการการชวนเพื่อนทำกิจกรรม (Frankel et al.,2010) การแสดงความคิดเห็นการริเริ่มมีปฏิสัมพันธ์การขอร้องผู้อื่น (Delano&Snell, 2006; Licciardelloetal., 2008) นอกจากนั้นการสื่อสารยังรวมไปถึงการมีระดับเสียงคำพูดสีหน้าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ (Charlopetal.,2010 รวมถึงการเข้าหาคนอื่น ๆ ด้วยท่าทางที่สังคมยอมรับ เช่น การเข้าพบผู้ใหญ่ ไม่ควรยืนคำศีรษะขณะที่ผู้ใหญ่ นั่งอยู่ ไม่ยืนหรือเดินประชิดตัวครูหรือผู้ใหญ่ การส่งงานในห้องพักอาจารย์ เป็นต้น

4) ทักษะการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อน การสร้างความเป็นเพื่อนและรักษาความเป็นเพื่อนไว้ เช่น “(ชื่อเพื่อน) เรานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับ” ส่วนการนัดเพื่อนต่างเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและมีความสำคัญในชีวิตวัยรุ่นคือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราสนใจทางเพศ อย่างไรก็ตามสำหรับคนจำนวนมากที่มีความบกพร่องทางสังคม การจะนัดสาวเป็นเรื่องใหญ่ที่น่ากลัวมาก แต่ถ้าด้วยทักษะสังคมที่เหมาะสมแล้ว การนัดสาวอาจเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายและสนุกสนานมากขึ้น การฝึกทักษะสังคมสำหรับการเดทประกอบด้วย 1) วางแผนนัดสาว 2) นัดสาว 3) เพิ่มความดึงดูดใจทางกายภาพ 4) จีบสาว: การสื่อสารและการสื่อสารด้วยวาจา 5) การชมเชยและรับชมเชย 6) การฟังอย่างตั้งใจ

5) ทักษะการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมจะมีความสนใจสิ่งแวดล้อมรอบด้านน้อยหากมอบหมายให้ทำงานกลุ่มบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมไม่สามารถจัดลำดับหรือแบ่งขั้นตอนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ผลลัพธ์ด้านนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของพวกเขาด้วย

10.2 โปรแกรมการฝึกทักษะสังคม SSI^{xxv}

การฝึกทักษะสังคม มีสำคัญในการพัฒนาความสามารถทางสังคม (social competence) มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้ทักษะสังคมมีความบกพร่องมากขึ้น และส่งผลเสียกระทบต่อด้านอื่น ๆ ในชีวิตด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อทักษะสังคมบกพร่อง ทำให้แยกตัวจากสังคม และการแยกตัวจากสังคม ทำให้ทักษะสังคมบกพร่องมากขึ้น ขณะเดียวกันการแยกตัวจากสังคมทำให้ความมั่นใจต่ำด้วย เป็นวงจรอุบาทว์ที่ส่งผลเสียถึงกัน (ภาพ 4) ดังนั้นการจัดการเพียงแง่มุมเดียวของวงจรโดยไม่สนใจแง่มุมอื่น ทำให้ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นการฝึกทักษะสังคมจำเป็นต้องจัดการหรือรักษาไปพร้อมกัน ซึ่งพบว่าการฝึกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการฝึกผ่านพ่อแม่ ร่วมกับการฝึกโดยตรง เพราะพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พฤติกรรมทางสังคมที่ต้องการสร้างนั้นมีความต่อเนื่องและคงทนอยู่ได้นาน^{xxvi, xxvii}



ภาพ 4 วงจรความบกพร่องทางทักษะสังคม

เป้าหมายในการฝึกทักษะสังคมแก่วัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม คือเพื่อการสอนให้เข้าใจความรู้สึกคนอื่น และสอนวิธีแสดงความห่วงใย/ตอบสนองทางอารมณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน โดยเน้น 1) สนับสนุนพฤติกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์สังคมเชิงบวก และ 2) สร้างกลวิธีเผชิญความเครียดเพื่อรับมือกับการกลั่นแกล้งและความกดดันข่มขู่ สิ่งเหล่านี้ส่งผลบวกให้เกิดความนับถือตนเองด้วย และสำคัญที่สุด ต้องจัดเตรียมสถานการณ์เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ทักษะและเสริมแรงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเป็นจริงในสถานการณ์ต่างๆ สอนให้ชัดเจน เพื่อที่เด็กจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างใดในสถานการณ์ต่างๆ และเสริมแรงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องบูรณาการกิจกรรมที่จำเป็น จะทำให้ได้ประสิทธิผลที่ดี

ทั้งนี้ต้องควบคู่กับการสอนทักษะสังคมพื้นฐานที่ยังติดขัด เช่น การสบตาการยิ้ม การเข้าใจภาษากาย การเริ่มต้น-สิ้นสุดการสนทนา การเริ่มต้น-สิ้นสุดการสนทนาที่ต่อเนื่อง การสื่อสาร online การเข้าใจภาษากาย การสร้างอารมณ์ขัน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การมีน้ำใจนักกีฬา เป็นต้น

10.2.1 วิธีการฝึกทักษะสังคม

การฝึกทักษะสังคมในบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม มีทั้งวิธีการฝึกรายบุคคลและการฝึกในกลุ่ม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการฝึกที่กำหนด ในกรณีการสอนบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการในการปรับตัว การรับรู้ และการแสดงออกทางภาษา และอื่น ๆ การฝึกควรเริ่มกิจกรรมการฝึกแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ฝึกกับเด็กเพื่อสร้างความคุ้นเคย แล้วจึงขยายไปสู่สังคมที่ใกล้ชิดตัวเด็กและกลุ่มอื่นๆ ต่อไป การฝึกแบบรายบุคคลจะใช้ในกรณีที่ต้องการปรับพฤติกรรมที่บกพร่องของเด็กเฉพาะราย เพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ต้องการสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีการประเมินทักษะสังคมของเด็กก่อน ข้อจำกัดสำหรับการฝึกรายบุคคลคือเด็กจะขาดการเชื่อมโยงพฤติกรรม (generalization) ไปในสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ที่ไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้^{xxviii,xxix} สำหรับการฝึกกลุ่มผู้ฝึกจะเน้นผลลัพธ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา (problem solving) การจัดการกับอารมณ์ การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน การทำงานร่วมกับผู้อื่น^{xxx xxxi,xxxii,xxxiii,xxxiv,xxv} ข้อดีของการฝึกวิธีนี้คือเด็กสามารถเลียนแบบพฤติกรรมในกลุ่มด้วย ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญในการฝึกทักษะสังคมคือลักษณะของเด็กและระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึก ดังนี้

1) **ลักษณะของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม** เนื่องจากแต่ละโปรแกรมจะมีการวัดผลลัพธ์ด้านทักษะสังคมที่แตกต่างกัน สิ่งที่สำคัญในการจัดโปรแกรมฝึกคือการแบ่งลักษณะของเด็กที่มีความคล้ายกันให้เข้ากับโปรแกรมนั้น ๆ โดยแต่ละโปรแกรมจะคำนึงถึงโรคและระดับสติปัญญา ซึ่งในกรณีที่เป็นการวินิจฉัยที่เลือกบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมโดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัย DSM-IV พบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมในการฝึกจะเป็นเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย Autistic disorder, Asperger disorder และ PDDNOS (pervasive developmental disorder-not otherwise specified) เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีความบกพร่องทางด้านสังคมที่สามารถสื่อสารเบื้องต้นได้^{xxvi,xxvii,xxviii} ส่วนเด็กกลุ่ม CDD (childhood disintegrative disorder) และ Rett's disorder จะไม่ได้รับเลือกเข้าฝึกเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่ต้องฝึกพัฒนาการด้านภาษาเบื้องต้นก่อน

เป็นส่วนใหญ่^{xxxix} ส่วนในด้านระดับสติปัญญานั้น สำหรับการฝึกทักษะสังคมในบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมวัยเรียน เด็กควรมีระดับสติปัญญาหรือไอคิวตั้งแต่ 70 ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าปกติ และหากเป็นทักษะสังคมที่ซับซ้อน เด็กควรมีระดับสติปัญญาตั้งแต่ 90 ขึ้นไปซึ่งอยู่ในระดับปกติ^{xl,xlix}

2) **ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกทักษะสังคม** บุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมวัยเรียน หากฝึกรายบุคคลจะใช้ระยะเวลาในการฝึกนานตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไป^{xliv} หากฝึกรายกลุ่มจะใช้ระยะเวลาค้างละ 60-90 นาที ฝึกสัปดาห์ละครั้ง 12 สัปดาห์ขึ้นไป^{xlv} อีกทั้งควรมีการติดตามผลและให้โปรแกรมเพิ่มเติมหลังจากได้รับโปรแกรมฝึกแล้ว ควรฝึกทักษะสังคมในช่วงต้นโดยเร็วตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ก่อนที่พวกเขาจะมีความสุขกับการแยกตัวจากสังคม และระวังการกลั่นแกล้งและการกดดันจากเพื่อน ซึ่งนอกจากส่งผลต่อความมั่นใจแล้วยังส่งผลให้เกิดการถอนตัวจากสังคม ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างรุนแรงในวัยหนุ่มสาว

10.2.2 เทคนิคในการฝึก

ในการฝึกทักษะสังคมบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมนั้น เพื่อให้เกิดการสร้างพฤติกรรมที่ดีและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะพบว่าแต่ละโปรแกรมจะมีการใช้เทคนิคในการปรับพฤติกรรมร่วมกับของทฤษฎีการเรียนรู้วางเงื่อนไข (operant conditioning)^{xlv} ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคม (social cognitive learning theory) ดังนี้

1) การให้แรงเสริม (reinforcement) เป็นเทคนิคที่สำคัญที่ทำให้พฤติกรรมมีความถี่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้การเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) หมายถึงสิ่งเร้าที่เมื่อให้แล้ว ทำให้เด็กเกิดความพอใจและทำให้เด็กมีการตอบสนองเพิ่มขึ้น เช่น อาหารคำชมเชย เงิน เป็นต้น การเลือกใช้แรงเสริมสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมนั้น จะต้องมีการประเมินความชอบของเด็กก่อน ซึ่งแรงเสริมที่เด็กชอบ ได้แก่ อาหาร ฟองสบู่ สติกเกอร์^{xlvi} และการชม^{xlvii}

2) การชี้แนะ (prompting) เทคนิคนี้ใช้เพื่อช่วยในการแต่งพฤติกรรม(shaping) ที่ต้องการสร้างให้กับบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม วิธีการชี้แนะมี 2 รูปแบบ คือ 1) การชี้แนะโดยการใช้คำพูด (verbal prompting) เช่น เมื่อฝึกพฤติกรรมการสื่อสารหลังจากดูวิดีโอ^{xlviii,xlix} แล้วเด็กไม่พูด ผู้ฝึกต้องใช้การชี้แนะโดยการถามนำ เป็นต้น และ 2) การชี้แนะโดยการใช้ท่าทาง (non-verbal prompting) ผู้ฝึกให้เด็กแสดงบทบาทสมมติ หากเด็กไม่สามารถแสดงได้ ผู้ฝึกจะชี้แนะและช่วยในการจับท่า การใช้เทคนิคนี้ร่วมกับการให้แรงเสริมเมื่อเด็กทำได้ถูกต้อง จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรมที่ต้องการสร้าง

3) การให้ข้อเสนอแนะ (feedback) เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการกระทำของบุคคล การให้ข้อมูลย้อนกลับเพียงอย่างเดียว อาจไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงควรนำไปสัมพันธ์กับตัวเสริมแรงอื่น ๆ เพราะจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือใช้เทคนิค feedback ร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ เช่น รูปแบบการใช้ผู้ใหญ่ฝึก ภายหลังจากให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมติแล้ว ผู้ฝึกให้ข้อเสนอแนะเด็ก สำหรับการปรับปรุงให้เหมาะสม เนื่องจากเด็กจะได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่แสดงถูกต้องหรือไม่ ผู้ฝึกจะได้ปรับแต่งให้พฤติกรรมของเด็กเหมาะสมและให้แรงเสริมทันที

4) การแสดงเป็นตัวอย่าง (modeling) เทคนิคนี้ใช้เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการให้เกิดจากแนวคิดของแบบดูราที่ว่า พฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดโดยการเรียนรู้จากตัวอย่างซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะเลียนแบบ จากนั้นจดจำและสร้างพฤติกรรมให้เกิดขึ้น ตัวแบบนั้นมีทั้งที่เป็นบุคคลและสัญลักษณ์ การฝึกที่ใช้ตัวแบบของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมแสดงบทบาทที่ต้องการสร้างให้เด็กดู จากนั้นให้เด็กปฏิบัติตาม ส่วนตัว

แบบที่เป็นสื่อ จะใช้วิดีโอให้เด็กดูและปฏิบัติตามพบว่าพฤติกรรมทางสังคมที่ต้องการสร้างก็ดีขึ้นเช่นเดียวกัน สิ่งที่สำคัญของเทคนิคนี้คือ ความถี่ของการสอนต้องสม่ำเสมอ

10.2.3 รูปแบบการฝึกทักษะสังคม

รูปแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีความหลากหลาย ซึ่งยังไม่มีรูปแบบใดที่ใช้ได้ดีกับกับเด็กทุกคน^{Li,lii} เช่น การสอนทักษะสังคมโดยตรง (direct skills instruction) การกระตุ้นเตือนก่อน (antecedent prompting) เพื่อนเป็นสื่อ (peer-mediated, peer tutoring, peer group) การดูแบบอย่างจากวิดีโอ (video modeling) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) การเข้าถึงมุขตลกต่าง ๆ (appreciation of humor) การมีผู้ช่วยเหลือ และเกม การอ่านจิตใจ (mind reading) เรื่องเล่าทางสังคม (social story) ฟลออร์ทิม (floor time) การควบคุมตนเอง (self-monitor) เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นว่ารูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้บุคคลที่มีภาวะออทิซึมสามารถพัฒนาทักษะสังคม แต่จำเป็นต้องเลือกอย่างรอบคอบและให้เหมาะสมกับความต้องการและระดับพัฒนาการของแต่ละคน ซึ่งอาจใช้หลายรูปแบบร่วมกัน รูปแบบที่ได้รับความนิยม เช่น

1) การใช้เรื่องเล่าทางสังคม (social story)

เรื่องเล่าทางสังคม พัฒนาโดยแคโรล เกรย์ (Carol Gray) เป็นการแต่งเรื่องเล่าขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะสังคมของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านเรื่องเล่าในหนังสือ โดยมีการกำหนดรูปแบบและวิธีการเขียนที่เฉพาะ เป็นวิธีที่ใช้จุดแข็งในการเรียนรู้ของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม คือ การใช้ภาพ ในสถานการณ์เฉพาะ ด้วยเรื่องราวสั้นกระชับ เป็นวิธีสร้างทักษะสังคมที่ไม่แพง และเน้นส่งเสริมความคิดเชิงบวก ด้วยการอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และการแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเช่น การเล่นเกม การแสดงสีหน้า การอ่านอารมณ์ ผู้อื่น เป็นต้น และแก้ไขพฤติกรรมทางสังคมที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว การไม่สามารถนั่งประจำที่ในห้องเรียนได้ เป็นต้น แม้ว่าการใช้เรื่องราวทางสังคมนี้จะเป็วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพแต่ก็มีข้อจำกัดคือสามารถฝึกได้เฉพาะพฤติกรรมที่นำมาเขียนเรื่องราวทางสังคม ไม่สามารถฝึกพฤติกรรมที่ซับซ้อนและเด็กไม่สามารถนำพฤติกรรมที่ฝึกไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้เนื่องจากไม่มีการฝึกในสถานการณ์จริง

2) การใช้วิดีโอเป็นแบบอย่าง (video modeling)

การฝึกโดยใช้วิดีโอเป็นแบบอย่างพัฒนามาจากแนวคิดของแบนดูรา (Bandura) ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กจะเกิดโดยการเรียนรู้จากตัวแบบ โดยต้องเกิดจากการมีความตั้งใจที่จะเลียนแบบ จากนั้นจดจำและสร้างพฤติกรรมให้เกิดขึ้นเหมาะสำหรับการฝึกรายบุคคล ข้อจำกัดของรูปแบบนี้คือไม่สามารถใช้สอนพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนมากได้และจำเป็นต้องหาสื่ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกเช่นเครื่องอัดวิดีโอเครื่องฉายวิดีโอ เป็นต้น

3) การฝึกโดยใช้เพื่อน (peer-mediated intervention:PMI)

เป็นรูปแบบที่ผู้ฝึกจะมีการฝึกเพื่อนเพื่อเป็นตัวแบบในการเล่นและช่วยและช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึม ซึ่งในการฝึกนี้ผู้ฝึกจะกำหนดทักษะสังคมเป้าหมายที่ต้องการฝึก เช่น การชักชวนให้ผู้อื่นสนใจการฝึกได้ตอบเมื่อเพื่อนชักชวน (social initiations) ฝึกการขอร้องและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมฝึกความสนใจขณะที่เพื่อนทำกิจกรรม การสลับกันเล่นตามหน้าที่และการร่วมกันแก้ปัญหา เป็นต้น โปรแกรมการฝึกโดยใช้กลุ่มเพื่อนมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้กลุ่มเพื่อนฝึกการ

สื่อสารในขณะที่เล่นเกมที่มีกฎกติกา ข้อจำกัดของรูปแบบนี้คือ สามารถทำได้เพียงกลุ่มเล็ก ๆ และทำเพียงในโรงเรียนเท่านั้น^{lviii}

4) การฝึกโดยใช้ผู้ปกครอง

เป็นรูปแบบการให้ความรู้และฝึกทักษะสังคมแก่ผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการดูแลและทำให้พฤติกรรมทางสังคมที่ต้องการสร้างนั้นมีความต่อเนื่อง และคงทนอยู่ได้นาน ประกอบด้วยการให้ความรู้และฝึกทักษะสังคมผู้ปกครองสอนสาธิตให้การบ้านผู้ปกครองกลับไปทำและมีการเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาภายหลังการฝึกรูปแบบนี้ได้ผลดีเพราะสามารถพัฒนาทักษะสังคมได้อย่างต่อเนื่องทั้งในสถานที่ฝึกและที่บ้าน ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ฝึกผู้ปกครอง เช่น Parent-assisted Children's Friendship training^{lv} พัฒนาโดย University of California, Los Angeles โปรแกรมที่ใช้ผู้ปกครองร่วมกับพี่น้องออทิสติกในการฝึกพฤติกรรมทางสังคมที่บ้าน เป็นต้น โดยมากจะประกอบด้วย การให้ความรู้และฝึกผู้ปกครองเพื่อไปฝึกทักษะสังคมของบุตรหลาน การสอนสาธิตให้การบ้านผู้ปกครองกลับไปทำ และมีการเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาภายหลังการฝึก รูปแบบนี้ทำให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะสังคมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานที่ฝึกและที่บ้าน

โดยสรุป วัยรุ่นที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัมมีความบกพร่องหลัก คือ การสื่อสาร พบว่ายังไม่มีโปรแกรมการสอนทักษะสังคมในหลักสูตรใด ๆ แม้จะเป็นทักษะที่มีความต้องการจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยหาโปรแกรมการพัฒนาทักษะสังคมของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม เพื่อให้ครอบครัวสามารถดำเนินการสอนทักษะสังคมแก่บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมที่ครอบครัวทำได้ และเป็นบริบทไทย โดยการฝึกฝนอย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ดูแลเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้เกี่ยวกับออทิสซึม และด้านการพัฒนาทักษะสังคมวัยรุ่นที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัมมีทักษะสังคมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง ด้านการสื่อความหมายกับบุคคลอื่น และด้านการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น โดยมีพื้นฐานจากการเข้าใจสิ่งที่ควรกระทำ เพื่อเปิดประตูสู่มิตรภาพ โอกาสในการมีงานทำ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นใบเบิกทางแห่งความสำเร็จ นำมาซึ่งความสุขในชีวิตต่อไป

11. เอกสารอ้างอิง (แนบท้าย)

12. ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

12.1 ด้านวิชาการ

- 1) ได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางในฝึกทักษะสังคม สำหรับวัยรุ่นที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม
- 2) ได้โปรแกรมฝึกทักษะสังคมของวัยรุ่นที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม และสามารถเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

12.2 ด้านสังคมและชุมชน

- 1) บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัมได้รับการพัฒนาทักษะสังคม สามารถแสดงออกทางสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อการปรับตัวสู่การดำเนินชีวิตในสังคมอนาคต ดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองตามศักยภาพได้ ลดอัตราการเจ็บป่วยจากปัญหาพฤติกรรมที่ซับซ้อน

2) ครอบครัวที่มีบุคคลออทิสซึมสเปกตรัม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสมาชิกในชุมชนได้อย่างกลมกลืน เข้าถึงบริการที่จำเป็นได้

3) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แนวทางในการเสริมสร้างทักษะสังคมของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมสเปกตรัม

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย

13.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาทักษะสังคมของวัยรุ่นที่มีภาวะออทิสซึม

14. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล

การทำวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมวิธี (mixed method) ชนิดตรวจสอบสองขั้นตอน (two-phase exploratory design) ในรูปแบบ (QUAN emphasized) โดยผลของระเบียบวิธีที่หนึ่งคือเชิงคุณภาพ (qualitative) ช่วยพัฒนาหรือเป็นข้อมูลในระเบียบวิธีที่สองคือเชิงปริมาณ (quantitative) โดยการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต้องแยกจากกัน ดำเนินการในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือน สิงหาคม 25621 – กรกฎาคม 2563 รายละเอียดของวิธีดำเนินการวิจัย มีดังนี้

14.1 กลุ่มเป้าหมาย

ระยะพัฒนาโปรแกรม: เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะสังคมของวัยรุ่นที่มีภาวะออทิสซึม รวม 11 คน ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะสังคมที่มีประสบการณ์ในการดูแลบุคคลออทิสซึมมากกว่า 3 ปี และหรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 3 คน อาจารย์ผู้สอนบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม ระดับอุดมศึกษา มาอย่างน้อย 3 ปีจำนวน 3 คน ผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมจำนวน 5 คน และ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโปรแกรม ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อพัฒนาโปรแกรมในขั้นต่อไป

ระยะทดลองใช้โปรแกรม: เป็นการวิจัยเชิงทดลอง และประเมินผลลัพธ์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 10-15 คน ที่กำลังศึกษาในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ในจังหวัดขอนแก่น ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิสซึมจากแพทย์ และครอบครัวยอมรับว่ามีความบกพร่องทางด้านปฏิสัมพันธ์การสื่อสารทางสังคม และพฤติกรรม เช่น มีความยากลำบากในการพูด การทักทาย การจัดการเงินทอง จัดตารางหรือกิจวัตรประจำวัน การปรับตัวด้านพฤติกรรม และยินยอมเข้าร่วมวิจัย สามารถใช้ภาษาไทยได้ และพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าร่วมการวิจัย โดยมี IQ>70 และไม่มีภาวะโรคร่วมทางกายและทางจิตชนิดอื่น (เช่น bipolar disorder, schizophrenia, or psychosis)

1) เกณฑ์คัดเลือกเข้าการวิจัย มีดังนี้คือ เป็นบุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ในจังหวัดขอนแก่น ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิสซึมจากแพทย์ และครอบครัวยอมรับว่ามีความบกพร่องทางด้านปฏิสัมพันธ์การสื่อสารทางสังคม และพฤติกรรม เช่น มีความยากลำบากในการพูด การทักทาย การจัดการเงินทอง จัดตารางหรือกิจวัตรประจำวัน การปรับตัวด้านพฤติกรรม และยินยอมเข้าร่วมวิจัย สามารถใช้ภาษาไทยได้ และพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าร่วมการวิจัย โดยมี IQ>70 และไม่มีภาวะโรคร่วมทางกายและทางจิตชนิดอื่น (เช่น bipolar disorder, schizophrenia, or psychosis)

2) เกณฑ์คัดออกจากการวิจัย มีดังนี้

- ครอบครัวที่ไม่สามารถเข้าร่วมกับโครงการวิจัยได้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตามเช่นอ่านไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ ไม่รู้หนังสือใด ๆ เลยหรือไม่สนใจใด ๆ เลย
- สำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึม มีเกณฑ์คัดออกคือ
- มีประวัติการเจ็บป่วยทางจิต (เช่น bipolar disorder, schizophrenia, or psychosis) จากประวัติการรักษา และการรายงานของพ่อแม่ และ IQ < 70
- มีความบกพร่องทางกาย ที่ขัดขวางการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น significant hearing or vision loss หูตึงมาก หรือตามองไม่เห็นที่รุนแรง ทดสอบการได้ยินโดยใช้วิธีง่าย ๆ คือ ถูนิ้วสองนิ้วซึ่งกันและกันห่างจากหูของผู้ป่วยประมาณ 1 นิ้ว ถูทีละข้าง ถ้าได้ยินเสียงนิ้วถูกันทั้ง 2 ข้างก็แสดงว่าหูยังได้ยินดี การมองเห็นทดสอบง่าย ๆ ด้วยการเห็นตัวหนังสือที่เขียนบนกระดานหน้าชั้นไม่ว่าจะใส่แว่นหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง others neurological disorders, e.g., cerebral palsy, phenylketonuria, tuberous sclerosis, neurofibromatosis, and seizure disorders, history of severe head trauma or stroke, โรคทางระบบประสาทและโรคทางกายอย่างอื่นตามที่กล่าวข้างต้น จะทราบได้จากประวัติ การตรวจร่างกายโดยจิตแพทย์ ถ้าจำเป็นก็ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการช่วย
- เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

14.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือในการวิจัย พัฒนาจากทบทวนวรรณกรรมและจากผู้เชี่ยวชาญประกอบ ด้วย เครื่องมือในการทดลอง และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้

14.2.1 เครื่องมือในการทดลอง ประกอบด้วยโปรแกรมการฝึกทักษะสังคม โดยมีร่างเนื้อหา ดังนี้

ครั้งที่	หัวข้อ	โปรแกรมการฝึกทักษะสังคม	การบ้าน
1.	ปฐมนิเทศ	พ่อแม่และวัยรุ่น ฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อทราบความสนใจหรือชอบ	วัยรุ่น ฝึกแลกเปลี่ยนข้อมูลทางโทรศัพท์กับเพื่อนในกลุ่ม
2.	ทักษะการสื่อสาร ภาษาพูด และภาษากาย	พ่อแม่และวัยรุ่น เรียนการสื่อสารสองทาง พ่อแม่ ค้นหากิจกรรมของวัยรุ่นที่จะมีเพื่อนเพิ่ม	วัยรุ่น ฝึกแลกเปลี่ยนข้อมูลทางโทรศัพท์กับเพื่อนนอกกลุ่ม
3.	ทักษะการสื่อสาร online:	การโทรศัพท์ การส่งข้อความ อีเมล ความปลอดภัยและการรับมือกับ cyber bullying	การเข้าใจภาษากาย
4.	เลือกเพื่อน	กลุ่มเพื่อน	วิธีการรับมือกับภัยมือถือ
5.	อารมณ์ขันที่เหมาะสม	อารมณ์ขัน ใช้และตอบสนอง	กลุ่มเพื่อนที่มี
6.	peer entry peer exiting	การเข้าหาเพื่อน ร่วมสนทนากับวัยรุ่นทำอย่างไรเมื่อล้มเหลว/เฟล	การใช้อารมณ์ขัน
7.	การเข้ากับเพื่อน	รวมพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างเล่น	การร่วมสนทนากับเพื่อน

		เกมและกีฬา	
8.	การนินทา การแกล้ง รังแก	การรับมือ จัดการกับอารมณ์ตนเอง	ความเป็นนักกีฬา
9.	ความกังวลและซึมเศร้าในวัยรุ่น	อาการและการวินิจฉัย, เทคนิคการผ่อนคลาย/ปรับตัว, การฝึกปฏิบัติ	การจัดการเมื่อถูกรังแก
10.	มิตรภาพต่างเพศ และการนัด	1) เรียนรู้พื้นฐาน 2) ฝึกปฏิบัติ	การคลายเครียด
11.	การสัมภาษณ์สมัครงาน part time	เทคนิคการสอบสัมภาษณ์	การนัดเพื่อนต่างเพศ
12.	End of Semester Party	งานเลี้ยงจบ	

14.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินผลลัพธ์ ประกอบด้วย

1) **Social Skills Rating System (SSRS; Gresham and Elliott 1990)^{iv}** The SSRS is a 52-item (secondary level parent form) and 51-item (secondary level teacher form) questionnaire assessing adolescent cooperation, assertion, responsibility, and self-control.

2) **Thai version of the Autism Treatment Evaluation Checklist: ATEC** (sensitivity = 94%, specificity= 61.9%)

3) **แบบวัดความรู้** เป็นแบบวัดความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

14.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

1) ยื่นโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

2) ผู้วิจัยนัดประชุมคณะนักวิจัยเพื่ออบรมชุดฝึกทักษะ และแบบประเมิน ก่อนนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

3) ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยประชุมผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะสังคมของวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม รวม 11 คน ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะสังคมที่มีประสบการณ์ในการดูแลบุคคลออทิซึมมากกว่า 3 ปี และหรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 3 คน อาจารย์ผู้สอนบุคคลที่มีภาวะออทิซึม ระดับอุดมศึกษา มาอย่างน้อย 3 ปีจำนวน 3 คน ผู้ปกครองบุคคลออทิซึมจำนวน 5 คน และ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโปรแกรม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อพัฒนาโปรแกรมในขั้นต่อไป

4) ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จำนวน 5 ท่าน และดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำก่อนนำไปใช้

5) ดำเนินการทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 10-15 คนที่กำลังศึกษาในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ในจังหวัดขอนแก่น โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์กำหนด และทำการประเมินก่อนดำเนินการ (T₁)

6) จัดโปรแกรม ครั้งละ 90 นาที สัปดาห์ละหนึ่งวัน รวม 12 สัปดาห์(X_{1-12}) และนัดมา boost ทุกเดือน อีก 3 ครั้ง และติดตามผลตามแบบประเมินผลการใช้โปรแกรมที่ได้ฝึกฝนไปตามตาราง

	สัปดาห์ที่																							
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ดำเนินโปรแกรม	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	X_{11}	X_{12}												
แบบประเมิน	T_1											T_2				T_3				T_4				T_5

7) โปรแกรมการฝึกทักษะสังคม ในแต่ละครั้งจะกำหนดช่วงเวลาดำเนินการดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	เวลา (นาที)
1	กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	10
2	ทบทวนการบ้าน (ประทับใจหรือมีอุปสรรคใดบ้าง)	5
3	ใบงาน 1 เราคิดว่า....คืออะไร (เช่น การนัดหมาย)	5
4	ใบงาน 2 เรามีจุดแข็ง/จุดอ่อนของการ.. (เช่น การนัดหมาย)..อย่างไร	5
5	ใบงาน 3: เราจะทำอย่างไรในการ... (เช่น การบอกคนอื่นว่าสนใจเขา)..	5
6	แสดงบทบาทสมมติ	30
7	พักรับประทานอาหารว่าง	15
8	อภิปรายวิธีการที่เหมาะสมในการ.... (เช่น จะบอกคนอื่นว่าสนใจเขา .. จะบอกนัดเขา).. และร่วมกันเขียนเรื่องเล่าทางสังคม (social story)	10
9	เวลาของพ่อแม่	5
	รวมเวลา	90

8) การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ T-Test ถ้าหากข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นปกติจะใช้สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์คือ Wilcoxon matched-pairs tests

15. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย

	เดือนที่											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	ทบทวนวรรณกรรม จัดทำโครงการ ขอ จริยธรรม	✓	✓										
2	ประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อชี้แจงรายละเอียด ของโปรแกรม และแบบประเมิน		✓										
3	ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม			✓	✓	✓							
4	ดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรม						✓	✓	✓				
5	จัดทำรายงานสรุปผลการวิจัย									✓	✓	✓	
6	เสนอผลการวิจัย												✓

16.งบประมาณของโครงการวิจัย

รายการ	จำนวน	
1. งบบุคลากร		
2. งบดำเนินการ		
2.1 ค่าตอบแทน		
1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ (1,000 * 16 คน)	16,000	บาท
2) ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง (300 * 26 คน * 3 ครั้ง)	23,400	บาท
3) ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา วันหยุดราชการ (420 * 8 คน * 8 วัน * 3 เดือน)	80,640	บาท
4) ค่าตอบแทนวิทยากร สอนทักษะสังคม (300 * 3 ชม * 8 วัน * 3 เดือน)	21,600	บาท
5) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลแบบวัด (100* 5 ชุด* 10 คน*5 ครั้ง)	25,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	0	
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	0	
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (130 * 10 คน * 10 ครั้ง)	13,000	บาท
3) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อ (role model, บทความ/หนังสือ,VDO modeling, Social story) (10,000 * 8 เรื่อง)	80,000	บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำ web page ทักษะสังคม รวมการออกแบบ การจัดการข้อมูลแบบมี interaction ดูแลระบบ (10,000 * 12 เดือน)	120,000	บาท

-ค่าจ้างเหมาสืบค้นข้อมูล (300 * 5 คน * 30 วัน)	45,000	บาท
4) ค่าขอจริยธรรม มข.1,000	1,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	0	
1) วัสดุ สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกจัดกลุ่มทักษะสังคม (1,000 * 12 ครั้ง)	12,000	บาท
2) วัสดุสำนักงาน ค่ากระดาษ ของจดหมาย ปากกา (1,000 * 12 เดือน)	12,000	บาท
3) วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ 2,500 *2 ตลับ, external hard drive ขนาดความจุ 2 terrabytes 5,000 * 1 อัน)	10,000	บาท
4) วัสดุอื่นๆ ของรางวัล/ที่ระลึก	5,000	บาท
3. งบลงทุน	0	
1) ค่าครุภัณฑ์ - ค่าโต๊ะเก้าอี้ครู และนักเรียน (6 ชุด x 4500 บาท)	27,000	บาท
4.ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน	30,000	บาท
รวมงบประมาณ	0	บาท

16. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

ลงชื่อ

(นางปริศนา อานจำปา)

หัวหน้าโครงการวิจัย

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- i Creswell, J.W., Clark, V.P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks: SAGE.
- ii Munhull, P.L. (1993). Epistemology in nursing. In P.L. Munhull, & C.O. Boyd. (Eds.), Nursing research: A qualitative perspective. New York: National League for Nursing.
- iii American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
- iv Coie, J., Terry, R., Lenox, K., Lochman, J., & Hyman, C. (1995). Childhood peer rejection and aggression as predictors of stable patterns of adolescent disorder. *Development and Psychopathology*, 7(04), 697–713.
- v Jeanie Tse, Jack Strulovitch, Vicki Tagalakis, Linyan Meng, Eric Fombonne. Social Skills Training for Adolescents with Asperger Syndrome and High-Functioning Autism. [Journal of Autism and Developmental Disorders](#) November 2007, 37(10), pp 1960–1968.
- vi Social Responsiveness Scale-Second Edition (SRS-2) rated by parents and blinded teachers. Secondary outcomes included parent- and teacher-rated adaptive behaviors, trainer-rated global functioning and clinical severity, and self-reported child and caregiver stress. Assessments were made at baseline, posttreatment, and at 3-months follow-up.
- vii [Laugeson EA, Frankel F, Gantman A, Dillon AR, Mogil C.](#) (2012). Evidence-Based Social Skills Training for Adolescents with Autism Spectrum Disorders: The UCLA PEERS Program. *J Autism Dev Disord* 42:1025–1036 DOI 10.1007/s10803-011-1339-1 (Volkmar et al. 2004; Reichow and Volkmar 2010; Reichow et al. 2012; Kasari et al. 2012; Matson et al. 2007).
- viii [Reichow B., Steiner AM, Volkmar F.](#) (2013). Cochrane review: social skills groups for people aged 6 to 21 with autism spectrum disorders (ASD). [Evid Based Child Health](#). Mar 7;8(2):266-315. doi: 10.1002/ebch.1903.
- ix Williams-White, S., Koenig, K., & Scahill, L. (2007). Social skills development in children with autism spectrum disorders: A review of the intervention research. *Journal of Autism & Developmental Disabilities*, 37, 1858–1868.
- x Webb, B. J., Miller, S. P., Pierce, T. B., Strawser, S., & Jones, P. (2004). Effects of social skill instruction for high-functioning adolescents with Autism Spectrum Disorders. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 19(1), 53–62.
- xi Barnhill, G. P. (2002). The effectiveness of social skills intervention targeting nonverbal communication for adolescents with Asperger syndrome and related pervasive developmental delays. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 17(2), 112.
- xii Provencal, S. L. (2003). The efficacy of a social skills training program for adolescents with autism spectrum disorders. Unpublished doctoral dissertation, University of Utah.
- xiii Webb, B. J., Miller, S. P., Pierce, T. B., Strawser, S., & Jones, P. (2004). Effects of social skill instruction for high-functioning adolescents with Autism Spectrum Disorders. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 19(1), 53–62.
- xiv Barnhill, G. P. (2002). The effectiveness of social skills intervention targeting nonverbal communication for adolescents with Asperger syndrome and related pervasive developmental delays. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 17(2), 112.
- xv Lopata, C., Thomeer, M. L., Volker, M. A., Nida, R. E. and Lee, G. K. 2008. Effectiveness of a manualized summer social treatment program for high-functioning children with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38: 890–904.

- xvi Gresham, F. M., Sugai, G., & Horner, R. H. (2001). Interpreting outcomes of social skills training for students with highincidence disabilities. **Exceptional Children**, 67(3), 331–344.
- xvii ชุตติกานต์ พินกุล และรินบุญ นุชน้อมบุญ. (2545). **การศึกษาค้นคว้าเรื่องเด็กออทิสติกกับการออกแบบและการจัดกิจกรรมศิลปะ**. เอกสารประกอบการรายงานวิชาทัศนศิลป์สำหรับการศึกษาพิเศษ. อัดสำเนา.
- xviii เพ็ญแข ลิ้มศิลา. (2545). “ออทิสซึมในประเทศไทย”: จากตำราสู่ประสบการณ์ ในเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเรื่องครู หมอ พ่อแม่: มิติการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- xix จอม ชุมช่วย. (2545). **เด็กออทิสติก**. เอกสารประกอบคำบรรยาย ณ ห้องประชุมการศึกษาพิเศษสถาบันราชภัฏสงขลา. อัดสำเนา.
- xx Baio, J., Wiggins, L., Christensen, D.L., et al. (2014). Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. **MMWR Surveill Summ** 2018; 67(No. SS-6):1–23. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss6706a1>.
- xxi อานนท์ บุญยรัตเวช. (2549). ออทิสติก. ค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2552. จาก www.thaimd.net/index.php?name=Forums&file...t=10
- xxii Frith, U. (2003). **Autism: explaining the enigma**. 2nd. Malden: MA Blackwell Publishing.
- xxiii Ministry of Education. (2000). **Teaching students with Autism a resource guide for school**. British Columbia: Canada Cataloguing in Publication Data.
- xxiv Mazefsky, C. A., Herrington, J., Siegel, M.,Scarpa, A., Maddox, B. B.,Scahill, L.,& White,S. W. (2013). The Role of Emotion Regulation in Autism Spectrum Disorder RH:Emotion Regulation in ASD.**Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry**, 52(7),679-688. doi:10.1016/j.jaac.2013.05.006
- xxv Choque Olsson N, Flygare O, Coco C, Görling A, Råde A, Chen Q, Lindstedt K, Berggren S, Serlachius E, Jonsson U, Tammimies K, Kjellin L, Bölte S. Social Skills Training for Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder: A Randomized Controlled Trial. **J Am Acad Child Adolesc Psychiatry**. 2017 Jul;56(7):585-592. doi: 10.1016/j.jaac.2017.05.001. Epub 2017 May 10.
- xxvi Radley, C. D., McHugh, M. B.,Taber,T., Battaglia, A. A., & Ford, W. B. (2015). School-Based Social Skills Training for Children With Autism Spectrum Disorder. **Focus on autism and other developmental disabilities**.1-13.doi:10. 1177/1088357615583470
- xxvii Hassenfeldt, T. A., Lorenz, J., & Angela Scarpa, A. (2015). A Review of ParentTraining in Child Interventions Applicationsto Cognitive–Behavioral Therapy for Children with High-Functioning Autism. **Journal Autism Development Disorders**, 2,79-90.doi:10.1007/s40489-014-0038-1
- xxviii นาลดา ตะวันกาญจน์โชติ. (2554). **การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมฝึกทักษะสังคมในเด็กออทิสติกสเปคตรัม**.สารนิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช,คณะแพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหิดล,กรุงเทพ.
- xxix Holloway, J., Healy, O., Dwyer, M., & Lydon, S. (2014). Social Skills Deficits in Children with Autism Spectrum Disorders : Evidence Based Interventions. In B. V. Patel, R. V. Preedy, & R. C. Martin (Eds.), **Comprehensive Guide to Autism** (pp.1133-1158). NewYork, NY : Springer New York.
- xxx Koning,C., Magill-Evans, J.,Volden, J., & Dick,B.(2013).Efficacy of cognitive behavior therapy-based social skills intervention for school-aged boys with autism spectrum disorders. **Research in Autism Spectrum Disorders**, 7(10),1282-1290.doi:http:// dx.doi.org/10.1016/j.rasd.2011.07.011
- xxxi Reichow, B., & Volkmar, F.R. (2010). Social skills interventions for individuals with autism: evaluation for evidence-based practices within a best evidence synthesis framework. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, 40(2), 149-166.doi:10.1007/s10803-009-0842-0

- xxxii Cotugno,A.J. (2009). Social Competence and Social Skills Training and Intervention for Children with Autism Spectrum Disorders. **Journal Autism Development Disorders**, **39**,1268-1277.doi:10.1007/ s10803-009-0741-4
- xxxiii Frankel, F.,Myatt,R., Sugar, C., Whitham,C., Gorospe,C. M., & Laugeson, E. (2010). A Randomized Controlled Study of Parent-assisted Children’s Friendship Training with Children having Autism Spectrum Disorders. **Journal Autism Development Disorders**, **40**, 827-842.doi:10.1007/s10803-009-0932-z
- xxxiv Koning,C., Magill-Evans, J.,Volden, J., & Dick,B.(2013). Efficacy of cognitive behavior therapy-based social skills intervention for school-aged boys with autism spectrum disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders*, **7**(10), 1282-1290.doi:http:// dx.doi.org/10.1016/j.rasd.2011.07.011
- xxxv Reichow, B., Steiner, A. M., & Volkmar, F. (2012). Social skills groups for people aged 6 to 21 with autism spectrum disorders (ASD). **The Cochrane Database Systemic Review**. (7), Cd008511.doi:10.1002/14651858.CD008511.pub2
- xxxvi Bock, M. A. (2007). The Impact of Social–Behavioral Learning Strategy Training on the Social Interaction Skills of Four Students With Asperger Syndrome. **Focus on Autism and Other Developmental Disabilities**, **22**(2),88-95
- xxxvii Frankel, F.,Myatt,R., Sugar, C., Whitham,C., Gorospe,C.M., & Laugeson, E. (2010). A Randomized Controlled Study of Parent-assisted Children’s Friendship Training with Children having Autism Spectrum Disorders. **Journal Autism Development Disorders**, **40**, 827-842. doi:10.1007/s10803-009-0932-z
- xxxviii Lopata,C., Thomeer,M. L., Volker, M. A.,Toomey,J. A., Nida, R.E., Lee, G. K., Rodgers, J. D. (2010).RCT of a Manualized Social Treatment for High-Functioning Autism Spectrum Disorders. **JournalAutism Development Disorders**,**40**,1297-1310.doi:10.1007/s10803-010-0989-8
- xxxix McKenzie, K. (2004). Autism:Explaining the Enigma. **Learning Disability Practice**, **7**,28.
- xl Frankel, F.,Myatt, R., Sugar, C., Whitham,C., Gorospe, C. M.,& Laugeson, E. (2010).A Randomized Controlled Study of Parent-assisted Children’s Friendship Training with Children having Autism Spectrum Disorders. **Journal Autism Development Disorders**, **40**,827-842. doi:10.1007/s10803-009-0932-z
- xli Lopata,C., Thomeer, M. L., Volker, M. A.,Nida,R. E., & Lee, G. K. (2008). Effectiveness of a Manualized Summer Social Treatment Program for High-Functioning Children with Autism Spectrum Disorders. **Journal Autism Development Disorders**, **38**, 890-904.doi:10.1007/s10803-007-0460-7
- xlii Lopata, C., Thomeer, M. L., Volker, M. A.,Toomey, J. A.,Nida, R. E., Lee, G. K., Rodgers, J.D.(2010). RCT of a Manualized Social Treatment for High-Functioning Autism Spectrum Disorders. **Journal Autism Development Disorders**,**40**,1297-1310.doi:10.1007/s10803-010-0989-8
- xlili Reichow, B., & Volkmar, F. R. (2010). Social skills interventions for individuals with autism: evaluation for evidence-based practices within a best evidence synthesis framework. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, **40**(2), 149-166. doi:10.1007/s10803-009-0842-0
- xliv Reichow, B., Steiner, A. M., & Volkmar, F. (2012). Social skills groups for people aged 6 to 21 with autism spectrum disorders (ASD). **The Cochrane Database Systemic Review**. (7),Cd008511.doi:10.1002/14651858.CD008511.pub2
- xlv Skinner,B.F. (1938). **The behavior of organisms: an experimental analysis**. Oxford, England:Appleton-Century.
- xlvi Owens,G., Granader, Y., Humphrey, A.,& Cohen,S. B. (2008). LEGO Therapy and the Social Use of Language Programme: An Evaluation of Two Social Skills Interventions for Children with High Functioning Autism and

Asperger Syndrome. **Journal Autism Development Disorders**, 38,1944-1957.doi: 10.1007/s10803-008-0590-6

- xlvi Licciardello, C. C., Harchik, A. E., & Luiselli, J.K. (2008). Social Skills Intervention for Children with Autism During Interactive Play at a Public Elementary School. **Education and treatment of Children**, 31(1), 27-37.
- xlvi Charlop, M. H., Dennis, B., Carpenter, M. H., & Greenberg, A. L. (2010). Teaching Socially Expressive Behaviors to Children with Autism Through Video Modeling. **Education and treatment of Children**, 33(3), 371-393.
- xlix Nikopoulos, C. K., & Keenan, M. (2007). Using Video Modeling to Teach Complex Social Sequences to Children with Autism. **Journal Autism Development Disorders**, 37, 678-693.doi:10.1007/s10803-006-0195-x
- I ผดุง อารยะวิญญู และคณะ. (2551). **วิธีสอนเด็กออทิสติก**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แว่นแก้ว.
- li Mesibov, G.B., Shea, V., & Schopler, E. et. l. (2004). **The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders**. United States of America : Springer.
- lii Roger, S. J. (2000). Interventions that Facilitate Socialization in Children with Autism. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, 30, 399-409.
- liii Holloway, J., Healy, O., Dwyer, M., & Lydon, S. (2014). Social Skills Deficits in Children with Autism Spectrum Disorders : Evidence Based Interventions. In B. V. Patel, R. V. Preedy, & R. C. Martin (Eds.), **Comprehensive Guide to Autism** (pp.1133-1158). NewYork, NY : Springer New York.
- liv Frankel, F., Myatt, R., Sugar, C., Whitham, C., Gorospe, C. M., & Laugeson, E. (2010). A Randomized Controlled Study of Parent-assisted Children's Friendship Training with Children having Autism Spectrum Disorders. **Journal Autism Development Disorders**, 40, 827-842.doi:10.1007/s10803-009-0932-z
- lv Gresham, F. M., & Elliott, S. (1990). The social skills rating system. Minnesota: American Guidance Service.